

34 - Hématome Rétro Placentaire - Pr. FAKHIR

Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui les mathèmes rétro-placentaires. C'est un cours de cinquième année de l'université de l'Université d'Ottawa, dans le module de gynécologie obstétrique. Les mathèmes rétro-placentaires appelaient aussi HRP, par abréviation, et appelaient aussi le DPPME, c'est-à-dire un décombement prématuré dans le placenta normalement atypique.

Ceci définit, en gros, l'événement constitutif de l'hématome rétro-placentaire. C'est un décollement du placenta, et donc l'hématome décolle le placenta de façon prématurée, c'est-à-dire que, normalement, le placenta se décolle après l'accouchement, au moment de la délivrance. Ici, c'est un décollement placentaire avant la période de la délivrance, donc il est prématuré.

Et c'est un placenta normalement inséré, et donc ce n'est pas un placenta bas inséré, parce que dans les placentas bas insérées, on peut avoir des décollements facilement, puisque le placenta intérieur est sur le segment inférieur, et dès que les premières contractions commencent, ils peuvent décoller le placenta. Et donc, l'achirpète propagandée, ou l'hématome rétro-placentaire, c'est un décollement prématuré du placenta qui est normalement inséré. C'est une hémorragie qui siège derrière le placenta, entre le placenta de la paroi et de l'héteros, et on parle de la plaque banale du placenta.

C'est un saignement qui est souvent non extériorisé, donc la quantité de saignement minime que peut avoir la façon de se former l'hémorragie n'est absolument pas proportionnelle à la quantité de saignement pour l'hématome minime. Et puis, il est secondaire à une désinsertion accidentelle d'une partie ou de la totalité du placenta d'un emballement inférieur. C'est un hématome qui peut survenir pendant la grotesque ou au cours du travail.

L'hématome rétro-placentaire est une extrême urgence médicale et obstétrique. Il a une évolution imprévisible. Il peut survenir dans les derniers mois de la grossesse ou au cours du travail.

Et c'est un accident grave qui peut entraîner des complications chez la mère ou chez le fœtus. Alors, ce qui arrive quand il y a un hématome qui décolle le placenta, c'est qu'il y a une interruption des échanges rétro-placentaire qui font qu'il y a une interruption de la vascularisation fœtale. Et en fonction de la surface de l'hématome, l'interruption va être plus ou moins importante.

Elle peut être totale si l'hématome décolle la totalité de la surface du placenta. Et ceci va donner rapidement une mort fœtale illimitée. L'hématome rétro-placentaire peut aussi être responsable de l'hémorragie maternelle par l'hématome.

Mais aussi par l'inertie utérine secondaire, ce qui peut donner une mortalité maternelle. La prise en charge de l'hématome rétro-placentaire est une prise en charge multidisciplinaire. Sur le plan

épidémiologique, l'incidence est entre 0,25 à 2,5% grossesse.

C'est une incidence très variable, vu que les moyens de diagnostic sont variables d'un pays à l'autre. Et surtout pour les formes frustres, dans le diagnostic ne se fait qu'à l'examen microscopique et dans le placenta. Ce qui fait que les pays où l'étude placenta est systématique et se fait de façon quotidienne, vont avoir des fréquences plus importantes à gérer.

4% des pré-eclampsies peuvent présenter une écharpée. L'âge moyen au Maroc et au Marrakech est exactement aux alentours de 20 millions. Et 50% des patients qui présentent une écharpée sont entre 25 et 35 ans.

C'est les âges qui concordent avec la littérature internationale, puisque la France aussi a un âge moyen de 30 millions. Et donc c'est les femmes et les hommes. Il y a un ensemble de facteurs de risque qui exposent à la survenue ou à la récurrence d'un hématome rétro-placentaire.

Un antécédent d'un hématome rétro-placentaire, une patiente qui a déjà fait une forme d'hématome rétro-placentaire peut en refaire. Un antécédent de pré-eclampsies ou qui partent en santé éparpillée. Antécédent de mort fatale immédiatement.

Le tabagisme avec une relation dose-à-effet. Les patientes qui ont un retard de croissance intra-utérin. Ou un contexte de thrombophilie.

La thrombophilie, c'est les anomalies actives ou innées de la coagulation dans les cas de maladies auto-immunes. La multiparité d'un facteur de risque. Et puis le traumatisme.

Soit le traumatisme direct sur l'abdomen comme dans les AVP. Ou les traumatismes minimes dans le cas par exemple de l'indigestion par manœuvre externe, etc. Les accidents paniculaires aussi peuvent être responsables d'un hématome rétro-placentaire.

Quand on a une réacté du cordon ou un circulaire du cordon. Et par traction sur le cordon, on peut avoir un souvenir d'un hématome rétro-placentaire. Alors voici un rappel sur l'anatomie du placenta.

Donc à gauche, vous voyez l'image du placenta par la face fœtale. C'est une face qui est couverte par l'agneau, c'est les membranes. Et qui est traversée par les vaisseaux ombilicaux.

Et elle est centrée par le départ du cordon ombilical. Ça s'appelle aussi la plaque coréale. A droite, c'est la face maternelle.

C'est-à-dire la face qui s'accolle normalement sur la paroi utérine. Et elle est formée par des côtes illégaux. Mais qui sont réguliers et lisses à la surface.

Et c'est sur cette face-là qu'on cherche l'hématome rétro-placentaire. Ceux forment une cupule, une dépression de ces côtes illégaux. Que laissent l'hématome contraire.

Et on part ici de la plaque basale. Sur le plan physiologique, si on veut se rappeler de la circulation utéro-placentaire. De bas en haut, on retrouve vers le bas, c'est la paroi utérine, myonociale.

Qui traverse ou qui donne des vaisseaux spiralés. Qui se déversent directement dans le placenta. Dans ce qu'on appelle les chambres intermineuses.

Et c'est cette zone rouge communicante. C'est ce qu'on appelle la chambre intermineuse. Le sang maternel se déverse directement dans cette chambre intermineuse.

A partir des artères spiralées. Que vous voyez en bas, qui sont en rouge, qui sont spirales. Et à l'intérieur de cette chambre, on voit ces digitations.

Alors ces digitations, ce sont les villosités coréales. C'est une unité fonctionnelle du placenta. Villosités coréales qui sont constituées par le tropoblast.

Mais qui sont centrées par un axe vasculaire. Qui vient à partir des vaisseaux ombilicaux. Les deux artères ombilicales.

Qui donne en bleu. Pourquoi en bleu ? Parce que c'est un sang qui est riche en CO₂. Et qui vient du fœtus avec les déchets.

Et qui va passer à l'intérieur des villosités. Et à travers cette membrane qui est constituée par le tropoblast. Il y aura les échanges entre ce sang ombilical.

Et le sang plutôt de la chambre intermineuse. Alors les échanges vont rendre ce sang riche en oxygène. Il va prendre le CO₂.

Et il va être enrichi en nutriments. Pour revenir à travers ce réseau rouge. Ce qui est celui de la veine ombilicale.

Qui ramène le sang oxygéné avec les nutriments. Vous voyez qu'il n'y a pas de communication directe. Entre le sang maternel et le fœtal.

Mais les villosités qui contiennent les axes vasculaires fœtales. Ils baignent dans la chambre intermineuse. Qu'est-ce qui se passe dans l'hématome rétro-placentaire ? C'est que quelques vaisseaux utérins.

De ces vaisseaux spiralés. Ils vont être rampés pour une cause ou une autre. Soit traumatiques.

Soit à cause qu'ils sont fragilisés. Soit à cause qu'il y a une hypertension artérielle. Soit à cause que ces vaisseaux ont gardé leur caractère oiseau actif.

Et qu'ils vont se contracter. Et qu'ils vont être thrombosés. Et ça va donner une suffusion sanguine.

Et après ils vont saigner. Et donc ça va créer l'hématome au niveau de cette plaque basale. C'est-à-dire vers le bas.

Entre la paroi utérine et cette placenta ou cette unité fonctionnelle. Sachez que, regardez en bas, c'est écrit que dans les artères spiralées. On a donc 85 mm d'écart.

Avec un débit de 650 m³ par minute. C'est un débit assez important. Qui fait que s'il y a un saignement.

L'hématome rétro-placenta peut évoluer rapidement. Et décoller toute cette partie basale du placenta. Si elle est décollée.

Les autres vaisseaux spiralés vont être détachés. Et la communication avec la chambre intervallaire va s'interrompre. Et donc il n'y aura plus d'échange entre le fœtus et la maman.

Et donc il y aura moins d'oxygénation. Ce qui va donner l'hypoxie. Et bien évidemment, les nutriments ne vont pas passer.

Et donc sur le plan anatomique macroscopique. Il y a une rupture de l'artère utéro-placentaire. Constitution d'un hématome dissiduel basale par décollement.

On dit basale parce que c'est au niveau de la plaque basale. Il n'est pas marginal vers la périphérie. Il est dans le centre de la plaque basale.

Interrompant la circulation materno-fœtale. Avec formation d'un caillou arrondi noirâtre. Adhérent et déprimant le placenta en lignes de poule.

Qui lie à la compression des cotylédons. Et l'hématome est toujours surmonté du niveau du placenta inverse. Sur l'image, l'hématome intra-placentaire.

Il est désigné par la flèche. Il est aigüé. C'est une collection de sang noirâtre.

Entre le placenta à droite. Déprimé sous forme d'une cupule convexe. Et la paroi utérine à gauche.

Qui ramène des petits vaisseaux spiralés. Qui s'interrompent et déversent du sang. Au niveau de cet hématome.

La zone qui est juste au-dessous de l'hématome. La zone placentaire. Elle est souvent infarctée.

C'est à dire qu'on a coupé l'arrivée du sang artériel. Mais aussi le retour sanguin. Ce qui fait qu'elle va être congestionnée.

Cet infarctissement peut être localisé au niveau de la zone placentaire. Mais aussi il peut être étouffé. Dans les formes dites graves d'apoplexie.

Il peut être étendu à l'utérus lumineux. Sur l'image à droite. Vous voyez que c'est un utérus qui est un peu bleu.

A part et d'autre il y a les trompes et les ovaires. Mais au centre ce qu'il y a. C'est un utérus mais qui est complètement bleu. C'est un utérus après extraction frotale.

Et après délivrance. Sur un acharpé. Ce qui se passe c'est qu'il y a. Une suffusion hémorragique de l'hématome.

A travers les fibres musculaires de l'utérus. Et ça nous donne ce qu'on appelle. Cette apoplexie utéro-placentaire.

Cette apoplexie et ses suffusions hémorragiques. Peut s'étendre au delà de l'utérus. Vers le petit morin.

Elle peut aussi se voir dans d'autres organes. Comme le foie morin. Ou le système d'ordre central.

Dans les formes avancées et graves de l'acharpé. Comme on va le comprendre plus tard. Il va y avoir.

Une coagulation travasculaire dissimulée. Qui va atteindre les viscères aussi. Et va entraîner les trombooses.

Et donc les empartissements. Mais il va entraîner aussi de l'hémorragie. Au intérieur de ces viscères.

Sur le plan microscopique. Donc c'est une connexion des massifs. Enserré dans un réseau fibrineux.

Les cellules environ. Les cellules entropblastiques. Contiennent de l'hémorragie derrière.

Les lésions sièges. Au niveau de la plaque basale. Parce qu'on peut avoir des lésions.

Au niveau de la plaque coréale. Et là on est dans les hématomes coriolis. On peut avoir des lésions périphériques.

Des lésions marginales. Comme vous voyez sur le schéma à droite. Et bien l'hématome rétroplacentaire.

Que l'on appelle l'épipénie. C'est celui qui est au bas et à droite. Et là on voit que c'est une cupule.

Convexe. Et qu'autour d'elle. Il y a un infartissement.

De l'hématome rétroplacentaire. Alors pour les autres. Décollements marginaux.

Et bien. Le décollement. Est périphérique.

Et il n'est pas. Convexe. Il est plutôt concave.

Et diffuse avec la forme. De la périphérie du placenta. Alors que l'hématome.

Type d'épipénie. Il est plutôt. Convexe.

Et les vaisseaux villositaires. Et utéroplacentaire. Peuvent montrer une oscillation.

Des trembances et des interruptions. Voici d'autres types d'hématomes. Qui peuvent exister.

C'est le subamniotique. Qui est juste sous les membranes. Donc à gauche.

Subchorionique. A droite. Il est sous le chorion.

Et pas obligatoirement. Sous le placenta. Et puis l'hématome rétroplacentaire.

Vrai. C'est celui qui est en bas. Qui a. Nommé rétroplacentaire.

Et bien. Là vous voyez que l'hématome. Il est convexe.

Il est limité par le placenta. Qui est infarti en regard. Et ça constitue une pupule.

Vous voyez. Et cette pupule on peut l'avoir macroscopiquement. Après la délivrance.

En examinant le placentaire. Alors. Il y a aussi des.

Des. Des hématomes. Subchorioniques et amniotiques.

Qui peuvent être volumineux. Et qui n'ont pas du tout le même pronostic. Que l'hématome rétroplacentaire.

Quelles sont les conséquences. De l'hématome rétroplacentaire. Et bien sachez que.

Comme on a expliqué. Qu'il s'agit d'un décollement. Placentaire.

Et qu'il y a une interruption des échanges. Dans la zone décollée. Et bien ça va entraîner.

Une souffrance fœtale. Surélie rapide. Qui peut entraîner.

La mort fœtale. Cette souffrance fœtale. Elle est d'autant plus aggravée.

Qu'il y a. Une hypoxie chronique. Pour. Dans le cadre.

D'une préclampsie. Ou d'un retard. Et cette souffrance aussi.

Est d'autant plus importante. Que la surface. De décollement par les hématomes.

Est importante. Quand la surface dépasse les 50%. Le risque de mort fœtale.

Est très important. A côté de cela. L'hématome rétro-placentaire.

Entraîne une hypertonie utérine. La augmentation du volume utérin. Par la présence de l'hématome.

L'utérus est une ensemble. Fermée. Dont les volumes sont.

Adaptés. De façon à ce qu'il n'y ait pas. Une hyper pression à l'intérieur de l'utérus.

Si l'hématome commence à saigner. Derrière le placentaire. Et à se replier.

Mais le volume augmente. Et la pression à l'intérieur de l'utérus augmente. Ce qui nous donne une hypertonie utérine.

C'est à dire. Un muscle utérin contracté. Qui ne se relâche pas du tout.

Et de là. On dit d'emblée. Qu'il y a un intérêt.

A chaque fois qu'on suspecte. Un hématome rétro-placentaire. De rendre rapidement.

L'hématome de façon artificielle. Afin de diminuer. La pression à l'intérieur de l'utérus.

Et ceci va améliorer. La perfusion fœtale. A côté de cela.

La libération en quantité importante. De prostaglandine. Pourrait également intervenir.

C'est à dire que. Au moment du décollement du placentaire. Il y a une libération.

Dans la circulation. Maternelle de prostaglandine. Mais aussi localement.

Qui vont aggraver un peu. L'hypertonie musculaire. A côté de tout cela.

Il y a le. La complication. Extrême qui peut survenir.

C'est le collapsus maternel. Puisque c'est un saignement interne. Qui n'est pas extériorisé.

Dont le volume est sous-estimé. A un certain moment. Il va entraîner.

Une baisse de la tension artérielle. Ce qui va encore. Augmenter.

Aggraver plutôt. La diminution de la vascularisation. Et donc.

L'asphyxie fœtale. Ce collapsus maternel. Est très important.

A diagnostiquer. Rapidement. Sinon cela va entraîner.

Une infusion. Fonctionnelle. Qui peut se compliquer.

Parfois. Ou rarement. La désinfection.

Peut être limitée. Sans un vrai retentissement fœtal. Ce n'est qu'à l'examen.

Que l'on découvre. Mais les formes parlantes. Bruantes et graves.

Sont les plus fréquentes. Parmi les. Lors du décomment.

Placentaire. Il y a une éruption. Dans la circulation maternelle.

Par infraction. Dans la chambre. Intervalleuse.

C'est une chambre qui va. S'ouvrir. Il va y avoir.

Une communication. Entre. La circulation maternelle.

Et lors du décomment. Il va y avoir un déversement. De matériel.

Tromboplastique. Dans le régime placentaire. En quantité importante.

Et ces produits là. Ils vont entraîner un emballement. Du mécanisme de la coagulation.

Dans tout le système vasculaire. C'est à dire. Il va y avoir de la coagulation.

Intravasculaire. Avec consommation importante. De phytonutrients.

De plaquettes. Et d'autres facteurs de la coagulation. C'est une des complications.

Les plus graves. Dans le cas de l'hématome rétro-placentaire. Alors.

Contre cette coagulation. Il va y avoir un accent fibrinolytique. Qui va se développer.

Et va libérer. Les PDF. Qui vont augmenter.

Et on sait que les PDF. Ont aussi un accent anticoagulant. Donc on a une thromopénie.

Des fibres immunogènes qui chutent. Et des PDF qui augmentent. Donc ceci.

Va obligatoirement augmenter. L'hémorragie dans l'hématome. Lui même.

Va aggraver l'apoplexie. Donc nous donnons un nom d'apoplexie. Le couvreur.

Il peut entraîner l'essuyement viscéral. Et on peut avoir. L'hémorragie de la délivrance.

Juste après l'accouchement. Parce que la patiente. Est entrée dans un cercle vicieux.

De coagulation intrafasculaire. Disséminée. Avec consommation des facteurs de coagulation.

Des plaquettes. Et donc l'hémostase. Va être difficile.

Les circonstances idéologiques. Sont très diverses. Donc il y a des mécanismes.

Très différents qui entraînent l'HRP. Dans beaucoup de morts mal connues. Mais les circonstances.

Les plus fréquentes. Et les plus connues. C'est l'ischémie.

Utéro-placentaire. Dans le cadre de la. Pathologie vasculaire.

Comme la prééclampsie. Alors. Nous connaissons.

La physiologie. De la prééclampsie. Vous savez que c'est un problème.

D'invasion trophoblastique. Au moment de la placentation. Une mauvaise qualité.

Du remodelage vasculaire. Artériel. Et l'attente spiralée.

Qui fait qu'ils gardent leurs oisillons contractions. Et donc ça entraîne des zones d'ischémie. Utéro-placentaire.

Qui peuvent. Donc entraîner l'ouverture. De certains vaisseaux.

Puis le traumatisme direct. Ou lors du versement du vaccin. L'amnésie synthétique.

L'évacuation. Et puis. Il y a pas mal de cas.

Où la cause n'est pas évidente. Et là on peut penser. A des maladies vasculaires locales.

Dans le cadre de la malnutrition. Le tabagisme. L'âge avancé.

Multiparité. Consommation de toxiques. Comme l'alcool.

Ou la cocaïne. Sur le plan études cliniques. On prend comme type de description.

Les formes. Ou la forme grave habituelle. Parce que c'est la forme habituelle.

De l'achapée. Il faut savoir que le diagnostic. De l'achapée ou la suspicion de l'achapée.

Est une suspicion clinique. Le diagnostic est un diagnostic clinique. Et à aucun moment.

On ne devrait attendre. La confirmation échographique. Ou biologique.

Pour dire que c'est un achapée. Si on a les signes cliniques évocateurs. On est en droit. De faire la prise en charge. Sur le plan général. La patiente peut présenter des signes. De prééclampsie. Soit déjà connu. Soit diagnostiqué.

Au même moment. Elle peut aussi présenter un état de choc. Elle va se plaindre. De douleur abdominale. D'installation brutale. En coup de poignard. Ou en coup de couteau. Des météorologies minimales. Qui ne sont pas. Concordantes. Avec l'état de choc. Présenté par la patiente.

Elle peut présenter des nausées. Rhumissement. Et puis à l'examen clinique. Soit on va retrouver les signes de choc. Notamment l'attaque cardiaque. La pulitité.

La chute de la tension artérielle. Soit on va trouver au contraire. Un signe de la puissance. Un signe d'une hypertension artérielle. On peut retrouver déjà. Des équipements de PTG.

Si le tableau est arrivé. Et la patiente est déjà. Puis la palpation de l'utérus. C'est très important. Parce qu'elle va nous donner. La contracture utérine. Qui est une contracture permanente. Et douloureuse. Avec une hyperesthésie cutanée.

On appelle ça. Un utérus de bois. Et ça signifie. Que la patiente est en contraction. Qui ne se relâche pas. Les contractions utérines habituelles. Elles sont paroxystiques. C'est à dire qu'il y a la contraction. Puis elle se relâche. Puis elle contracte. Puis elle se relâche. Donc on dit que c'est un utérus. Tendue. Qui ne relâche pas. Et puis à l'examen.

On devrait vérifier. Les bruits cardio-sotaux. Qui parfois peuvent être négatifs. Soit parce qu'on n'arrive pas à les entendre. Parce qu'il y a une contracture. Soit parce qu'il y a une mort totale.

Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est que la paraclinique. Ne doit absolument pas retarder. La prise en charge. Mais parfois. Si on entend les bruits cardio-sotaux. On peut avoir recours. A des contractions. D'un côté elle peut confirmer la mort totale.

D'un autre côté on peut visualiser. L'hématome rétro-placentaire. Sous forme de myomes anécogènes.

Étalées et biconvexes. Au niveau de la plaque. Malade du placenta.

Parfois. On peut avoir des images atypiques. Qui ne sont pas du tout évocatrices.

Comme des images hétérogènes. Au tout début de l'hématome. Et qui sont difficiles à visualiser.

L'hématome va être plus visible. Quand il est liquéfié. Il y a quelques heures qui sont passées.

Pour qu'il apparaisse. Un écougéno noirâtre. Derrière le placenta.

Puis on devrait faire un bilan. Biologique. Dans le cadre de la prise en charge.

Notamment la NFS. Le bilan des moustaches. Le groupage.

Et faire la demande de sang. Et le bilan de la pré-éclampsie. Donc ici il y a une image.

D'une zone hypo-écogène. Derrière le placenta. Qui peut évoquer.

Un hématome rétro-placentaire. Là aussi c'est une image. Convexe.

Hypo-écogène. Donc un peu noir. Mais hyper-écogène.

Derrière le placenta. La zone homogène. Blanchâtre.

Hyper-écogène. La flèche rouge montre. L'hématome rétro-placentaire.

Sur le plan clinique. Sachez que l'hématome rétro-placentaire. peut se présenter.

Sur plusieurs formes. La forme typique et complète. C'est là où on a tous les signes.

Notamment la prière. L'hémorragie. L'hypertonie utérine.

C'est un signe évocateur. Et presque. Et puis les BTF négatifs.

Si on a les trois. Ça veut dire que presque à 100%. On a un hématome rétro-placentaire.

C'est le tableau coupé. Mais on peut avoir des formes. Aussi symptomatiques.

Avec deux signes. Ou moins. Par exemple.

On peut avoir juste l'hémorragie et l'hypertonie utérine. Ou l'hémorragie et des BTF négatifs. En forme.

Un semi-signes. L'hémorragie isolée. L'hypertonie isolée.

Où la mort totale et l'hypertonie isolée. Ou une souffrance peut-être entracée. Mais qui n'est expliquée par rien d'autre.

Donc ça peut être un signe d'un hématome rétro-placentaire. Il y a aussi les formes asymptomatiques. Où il n'y a aucun signe clinique de la crotte.

Mais que à l'examen du déliv. On retrouve l'hématome. Comme on le dit.

Et puis il y a les formes associées. A une pathologie obstétrique. À l'ingénieur clinique.

On peut retrouver un achèvement. Associé avec l'anxiété. Un placenta prévié.

Surveillance sur un conseil général. Ou chez des patients. Qui ont une maladie abortif.

Et généralement là. On doit penser à des pathologies auto-immunes. Trombophiliques.

Et donc. Il y a eu plusieurs classifications. De ces hématomes rétro-placentaires.

Par rapport au tableau clinique. Certains les classifient. Sous forme de forme grave.

Avec sous-titres vivants. Forme frustrée. Forme latente avec mort fœtale.

Les formes étendues apoplexiques. Et les formes compliquées. Compliquées de mort fœtale.

Compliquées de COPD. Des hématomes syndromes. Des clampsies.

Mais la classification de chair. Est l'une des classifications les plus pratiques. Par rapport à la conduite à tenir.

Ultra. Et là. Elle est classée en 3. Ou on va dire en 4. Alors le grade 1. Contient uniquement des métrorradies isolées.

Le grade 2. Contient une symptomatologie clinique plus complète. Mais avec un fœtus vivant. Le grade 3. Où on a une mort fœtale.

Ça peut être un 3A. Et donc on a la symptomatologie clinique. Mais fœtus mort.

Et pas de troubles de la coagulation. Et 3B. Symptomatologie clinique.

Mort fœtale. Et troubles de la coagulation. L'évolution de la chair P. Donc comme on a vu tout à l'heure.

C'est une pathologie qui est. Imprévisible. Et une évolution rapide.

Et donc si on n'agit pas rapidement. On peut avoir des. Troubles de la crasse sanguine.

Comme on a expliqué la 3B. L'atomie utérine par l'oxygène. Le choc hémorragique.

On peut avoir de l'hémoanurie. Par insuline rénale. Et puis on peut avoir.

Mort fœtale. Ou plutôt la mort maternelle. Qui peut survenir.

Au cours de toutes ces complications. Et bien évidemment. La souffrance fœtale.

Ou la mort fœtale. Quels sont les diagnostics différentiels. De l'hématome rétro-placentaire.

Et bien c'est les diagnostics. Au contrôle de chacun des symptômes. Notamment la métrorragie du 3ème trimestre.

Et bien ça peut être. Rhinocérpée. Mais aussi ça peut être un placenta papillaire.

Malades d'accouchement prématuré. Un hématome de suture marginal. Ou des lésions cervicales ou vaginales.

Traumatiques ou infectieuses. Ou tumorales. Pour la douleur abdominale aiguë.

Il ne faut pas oublier. Les symptômes douloureux aigus. Chirurgicaux.

On peut avoir exceptionnellement. Une rupture utérine. Ou une choréamniose.

Et l'image échographique. Il faut savoir que l'échographie n'est pas. Dans le moyen diagnostique de l'hémorragie rétro-placentaire.

Mais il peut le suspecter aussi. Parce qu'on peut avoir. D'autres hématomes.

Qui donnent des images. Qui ressemblent à l'HRP. Et aussi.

Des tumeurs placentaires. Qui peuvent avoir un aspect. Pour écogène et terrestre.

Quelle est la conduite à tenir. De vos suspicions d'HRP. Et bien tout d'abord l'action.

Va être dictée selon la gravité. Si on est dans un état de choc. Donc.

La conduite doit être. Comme une extrême douceur. Sinon.

On peut prendre le temps d'agir doucement. Mais les principes. Sont les mêmes.

Alors on doit faire une mine en condition. Avec des voies veineuses. Et la protéine microbienne.

Mettre en place une sonde vésicale. Qui va nous permettre de surveiller. L'oligurie.

Et aussi de faire un prélèvement pour la protéine. Donc faire Doubler la borne du lait urinaire. Trois objectifs.

Le traitement du choc. L'évacuation utérine. En urgence.

Parce que le traitement de l'hématome. Retroplacentaire. C'est l'accouchement et la délivrance.

Corriger les troubles de l'hématase. S'il existe. Donc on doit procéder.

Après la mise en condition. Au prélèvement sanguin. Les TCR.

Notamment le comptage sanguin. Les NFS de plaquettes. Les TPCR.

L'ionogramme sanguin. Le Recreate. La protéinurie.

Et tout ceci. Devrait être fait rapidement. Sans retarder la prise en charge.

Sans attendre le bilan. Surtout. Sans attendre les résultats.

Si on a un tableau clinique évocateur. Ou si on a un patient qui est instable. Alors.

Le principe. Du traitement de l'hématome. Retroplacentaire.

C'est l'évacuation de l'utérine. On ne peut pas concevoir. Une prise en charge d'un HRT.

En expectative. On n'a rien à attendre. Dès qu'on suspecte un HRT.

Ou qu'on est sûr que c'est un HRT. On doit aller faire. L'évacuation utérine.

Quel que soit le terme. Parce qu'à ce moment-là. On est dans le sauvetage maternel.

Alors. En fonction de la situation. La voie de cette évacuation va changer.

Si on est dans le cadre d'un fœtus mort. Et là on est dans le grade 3. De chair. On peut activer la voie basse.

A condition que la patiente soit stable. Et qu'il n'y ait pas de trouble. De la coagulation.

Donc on est dans le 3A. Et donc là. On fait une rupture large des membranes.

On fait un déclenchement artificiel du travail. Par les ossitocytés. Si l'échec du déclenchement.

C'est un césarien. Si les conditions obstétricales. Ne sont pas adaptées.

A l'accrochement de la voie basse. On doit faire un césarien. Si on est dans un moment cicatriciel.

Si on est dans un. Présentation transversale. Si c'est une gémellère.

Un premier transverse. Et bien. On fait un césarien.

La voie basse est acceptée. Si les conditions obstétricales. Ne sont pas adaptées.

Maintenant le grade 3B. C'est à dire un fœtus mort. Avec des troubles de la coagulation.

C'est une indication de césarien. Quand le fœtus est vivant. Ou viable.

C'est un césarien. En extrême urgence. Pour un sauvetage ici.

Ça va être maternel fatal. Bien sûr. Sauf si la patiente se présente.

En dilatation complète. Là on accepte. A côté de la prise en charge.

Obstétrique. On doit traiter les chocs. Tout en sachant.

Que le seillement extériorisé. Est toujours inférieur à la départition sanguine. Réelle.

En respectant les règles signes. De la transfusion sanguine. On peut transfuser le sang.

Les cristallinides. Et les électrolytiques. Et puis prévenir.

Et traiter l'hémorragie. De la délivrance. En faisant une délivrance.

Vérifiée. Et en prenant en charge. Rapidement.

Médicalement. L'hémorragie. Du COS par contre.

Puis traiter les troubles de la coagulation. Donc ceci doit se faire. De façon précoce.

Et il faut lutter contre. La coagulation intravasculaire dissimulée. En.

Utilisant. Transfusion du plasma. Très congelé.

Transfusion des plaquettes. Transfusion des facteurs de la coagulation. Alors à côté de ça.

Il ne faut pas du tout négocier la prise en charge. De la prévalence. Si elle est coexistante.

Notamment par le traitement anti-hypertenseur. Et le stigmat de magnésium. Alors sachez que le pronostic.

Dans la CRP. Dépend de la rapidité de la prise en charge. Que ce soit le pronostic.

Rétal ou le pronostic maternel. Plus on fait l'extraction. Rapidement.

Plus on a de chances de sauver. Mais à condition. Que le foetus soit viable.

Si on est dans la grande prématuré. Et dans la grande prématurité. On va faire obligatoirement l'extraction.

Parce qu'on a un sortage maternel après. Mais on sera confronté. Au problème de la prématurité.

Alors sachez que la mortalité. Fatale peut atteindre. 30 à 60%.

Et la mortalité maternelle. Est à l'entour de 1%. Elle est liée surtout.

Aux complications. Est-ce qu'il y a un traitement. Préventif de la CRP.

Et bien oui. C'est le même traitement préventif. De la prééclampsie.

Notamment. 75 à 100mg par jour. Et qui doit être indiqué.

Chez les patients qui ont des facteurs de risque. Comme un décès d'un HRP. Un décès d'un prééclampsie.

Un décès d'un enfant de 3 centimètres. Ou de pathologie auto-immune. Il faut aussi.

Prédire du calcium. Donc 1 à 2 prises par jour. Qui actuellement.

Constitue une recommandation. Pour la prévention de la prééclampsie. Donc en conclusion.

Sachez que l'hématome. Rétroplacentaire. Compte presque 4% des prééclampsies.

Avec. Un caractère de survie. Brutale et imprévisible.

Un diagnostic. Souvent facile. Parce que le tableau est typique.

Mais parfois. Difficile et frustrant. Des complications.

Comme l'assimilé. L'insuline adrénaire. La mort crénale.

Les matériaux. Peuvent se réunir. Par exemple.

Et il faut. Bien évidemment. Une prise en charge multidisciplinaire.

Qui comprend. L'obstétricien. Le rhumatologue.

Et le néphrologue.